COPD 관리는 금연·운동·백신·흡입제

만성폐쇄성폐질환(COPD)은 공기를 내보내는 기능이 지속적으로 떨어지는 병입니다. 증상이 가벼워도 폐기능 검사 결과와 함께 관리합니다.

생활관리와 약물치료를 함께 이어갑니다



금연, 운동·호흡재활, 호흡기 백신과 흡입 기관지확장제가 COPD 관리의 축입니다.

담배만 원인은 아닙니다

금연과 노출 이력

흡연 외에도 직장에서 오랫동안 분진이나 가스에 노출되면 COPD가 생길 수 있습니다.
금연클리닉과 연결해 금연을 이어갑니다.

운동과 호흡기 백신

증상이 없거나 가벼울 때도 운동과 백신을 함께 고려합니다. 강의에서는 RSV를 포함한 호흡기 백신을 강조했습니다.

COPD와 천식은 기본 흡입제가 다릅니다

COPD	흡입 항콜린제(LAMA)와 흡입 베타항진제(LABA)를 함께 쓰는 기관지확장제가 중심입니다. 필요에 따라 흡입 스테로이드를 더합니다.
천식	흡입 스테로이드와 흡입 베타항진제가 중심입니다. COPD와 같은 약이라고 생각해 바꾸지 않습니다.

치료의 목표는 생활과 악화를 함께 개선하는 것

강의에서는 약물치료가 삶의 질과 악화 예방에 효과적이라고 설명했습니다. 생활관리와 흡입제 치료를 함께 이어갑니다.

광교바른내과 · 031-893-4560
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호
소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

운동의 이득과 폐기능 수치는 구분해요

검사 숫자가 올라야만 운동이 효과가 있는 것은 아닙니다.

운동으로 기대하는 변화

증상·운동능력·악화 예방

연자 Q&A에서는 만성 호흡기질환의 운동이 삶의 질과 증상, 운동능력, 악화 예방에 도움이 된다고 설명했습니다. 속보·조깅·수영·등산 같은 유산소 운동과 보조적인 근력운동을 소개했습니다.

폐기능 수치의 회복과는 다릅니다

연자 Q&A에서는 COPD 환자가 유산소 운동을 한다고 폐기능 수치가 더 좋아지는 것은 아니라고 설명했습니다. 비만으로 폐기능이 떨어진 경우 체중감량 효과와도 구분합니다.

폐기능 검사는 이렇게 이해합니다

FEV1/FVC	한 번에 내쉰 전체 공기 중 첫 1초에 나온 양의 비율입니다. 강의의 폐쇄성장애 기준은 0.7 미만입니다.
지속적인 평가	COPD는 지속적인 폐쇄성장애, 천식은 증상과 폐기능의 변동성이 특징입니다. 한 시점의 정보만으로 둘을 모두 가리기 어렵습니다.
검사 노력	깊게 들이마시고 끝까지 강하게 내쉬어야 합니다. 노력에 따라 낮게 나올 수 있어 반복 검사를 고려합니다.

진료 때 함께 살필 것

1. 증상의 변화와 실제 흡입제 사용 내용을 전합니다.
2. 금연·운동 실천, 호흡기 백신 접종 기록을 함께 봅니다.
3. 폐기능 검사 결과를 비교하며 지속 치료 계획을 맞춥니다.

광교바른내과 · 031-893-4560
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호
소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/respiratory/asl28-copd-daily-care-and-treatment/